F- LE CANCER DE LA VULVE

1- Maladie localisée :

5FU + CISPLATINE J1=J28 RCC: [1]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	2L de SS 0,9% ou SG5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Aprepitant	125.0 mg	orale	45min avant cisplatine
5	Chimiothérapie	Fluorouracil	4000.0 mg/m²	Intraveineuse	Dans SS 0,9% en perfusion continue sur diffuseur portable sur 5 jours (j1j2j3j4j5)
J2					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	2L de SS 0,9% ou SG5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Cisplatine	100.0 mg/m²	Intraveineuse	Dans 500 cc SS 0,9% en 1 H puis rinçage j2
5	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h

[1] : J S Berek 1, J M Heaps, Y S Fu, G J Juillard, N F Hacker , Concurrent cisplatin and 5-fluorouracil chemotherapy and radiation therapy for advanced-stage squamous carcinoma of the vulva , Gynéco-oncologie .1991 septembre;42(3):197-201. doi: 10.1016/0090-8258(91)90345-6.

CAPECITABINE + CISPLATINE J1=J28 RCC :[2]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	2L de SS 0,9% ou SG5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Chimiothérapie	Capecitabine	825 mg/ m²	orale	2x/j matin et soir 30 min après le repas, 5 jours sur 7, pendant toute la durée de la radiothérapie
J2					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	2L de SS 0,9% ou SG5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Aprepitant	125.0 mg	orale	45min avant cisplatine
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Cisplatine	100.0 mg/ m²	Intraveineuse	Dans 500 cc SS 0,9% en 1 H puis rinçage j2
6	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h

[2] : van Triest B, Rasing M, van der Velden J, et al.. Phase II study of definitive chemoradiation for locally advanced squamous cell cancer of the vulva: an efficacy study. Gynecol Oncol 2021;163:117–24. 10.1016/j.ygyno.2021.07.020.

CISPLATINE J1=J8 RCC: [3]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	2L de SS 0,9% ou SG5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Aprepitant	125.0 mg	orale	45min avant cisplatine
4	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Cisplatine	40.0 mg/m²	Intraveineuse	Dans 500 cc SS 0,9% en 1 H puis rinçage j2
6	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h

[3] : *Moore DH, Ali S, Koh WJ, Michael H, Barnes MN, McCourt CK, Homesley HD, Walker JL. A phase II trial of radiation therapy and weekly cisplatin chemotherapy for the treatment of locally-advanced squamous cell carcinoma of the vulva: a Gynecologic Oncology Group study. Gynecol Oncol. 2012 Mar;124(3):529-33. Epub 2011 Nov 9.*

2- Maladie métastatique :

CISPLATIN + PACLITAXEL J1=J21: [5]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	2L de SS 0,9% ou SG5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Aprepitant	125.0 mg	orale	45min avant cisplatine
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	175 mg/m²	Intraveineuse	Perfusion intraveineuse dans 500 ml de chlorure de sodium de chlorure de sodium 0,9 % en 180 minutes.
J2					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	2L de SS 0,9% ou SG5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Cisplatine	50 mg/m²	Intraveineuse	Dans 500 cc SS 0,9% en 1 H puis rinçage j2
5	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h

[5] : Rose, P. G., Blessing, J. A., Gershenson, D. M., & McGehee, R. (1999). Paclitaxel and cisplatin as first-line therapy in recurrent or advanced squamous cell carcinoma of the cervix: A Gynecologic Oncology Group study. Journal of Clinical Oncology, 17(9), 2676–2680. https://doi.org/10.1200/JCO.1999.17.9.2676

CARBOPLATINE + PACLITAXEL J1=J21 [6]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Paclitaxel	175 mg/ m²	Intraveineuse	Perfusion intraveineuse dans 500 ml de chlorure de sodium de chlorure de sodium 0,9 % en 180 minutes.
4	Chimiothérapie	Carboplatine	AUC 5	Intraveineuse	Perfusion intraveineuse dans 500 ml de glucose 5% sur 60 minutes
5	Post-hydratation (Rinçage)	Chlorure De Sodium	250.0 ml	Intraveineuse	250 ml de SS 0,9%

[6] : Tinker, A. V., Bhagat, K., Swenerton, K. D., & Hoskins, P. J. (2005). Carboplatin and paclitaxel for advanced and recurrent cervical carcinoma: The British Columbia Cancer Agency experience. Gynecologic Oncology, 98(1), 54–58. https://doi.org/10.1016/j.ygyno.2005.03.037

PACLITAXEL J1, J8, J15 J1=J28 : [10]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie

3	Chimiothérapie	Paclitaxel	80 mg/m²	Intraveineuse	Perfusion intraveineuse dans 250 ml de chlorure de sodium 0,9 % pendant 60 minutes
4	Post-hydratation (Rinçage)	Chlorure De Sodium	250.0 ml	Intraveineuse	250 ml de SS 0,9%

[10] : Machida, H., Moeini, A., Ciccone, M. A., Mostofizadeh, S., Takiuchi, T., Brunette, L. L., Roman, L. D., & Matsuo, K. (2018). Efficacy of modified dose-dense paclitaxel in recurrent cervical cancer. American Journal of Clinical Oncology, 41(9), 851–860. https://doi.org/10.1097/COC.0000000000000394

CISPLATINE+ PACLITAXEL+ BEVACIZUMAB J1=J21: [4]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	2L de SS 0,9% ou SG5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Aprepitant	125.0 mg	orale	45min avant cisplatine
5	Thérapie ciblée	Bevacizumab	15 mg/ m2	Intraveineuse	Perfusion intraveineuse dans 100 ml de chlorure de sodium de chlorure de sodium 0,9 % en 90 minutes.
6	Chimiothérapie	Paclitaxel	175 mg/m²	Intraveineuse	Perfusion intraveineuse dans 500 ml de chlorure de sodium de chlorure de sodium 0,9 % en 180 minutes.

J2					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	2L de SS 0,9% ou SG5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Cisplatine	50 mg/ m²	Intraveineuse	Dans 500 cc SS 0,9% en 1 H puis rinçage j2
5	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h

[4] : Tewari, K. S., Sill, M. W., Long, H. J., Penson, R. T., Huang, H., Ramondetta, L. M., Landrum, L. M., Oaknin, A., Reid, T. J., Leitao, M. M., Michael, H. E., & Monk, B. J. (2014). Improved survival with bevacizumab in advanced cervical cancer. The New England Journal of Medicine, 370(8), 734–743. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1309748

CARBOPLATINE + PACLITAXEL + BEVACIZUMAB J1=J21 [9]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Thérapie ciblée	Bevacizumab	15mg/m2	Intraveineuse	Perfusion intraveineuse dans 100 ml de chlorure de sodium de chlorure de sodium 0,9 % en 90 minutes.
4	Chimiothérapie	Paclitaxel	175 mg/ m²	Intraveineuse	Perfusion intraveineuse dans 500 ml de chlorure de sodium de chlorure de sodium 0,9 % en 180 minutes.

5	Chimiothérapie	Carboplatine	AUC 5	Intraveineuse	Perfusion intraveineuse dans 500 ml de glucose 5% sur 60 minutes
6	Post-hydratation (Rinçage)	Chlorure De Sodium	250.0 ml	Intraveineuse	250 ml de SS 0,9%

[9] : Tao, W., Yang, J., Jiang, Y., Chen, W., & Wang, Y. (2020). Paclitaxel, carboplatin, and bevacizumab in advanced cervical cancer: A treatment response and safety analysis. Medicine, 99(31), e21410. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000021410
PMCID: PMC7391439 | PMID: 32774193

PEMBROLIZUMAB + CiSPLATINE+ PACLITAXEL+/- BEVACIZUMAB J1=J21 : [7]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	2L de SS 0,9% ou SG5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Pré-médication	Aprepitant	125.0 mg	orale	45min avant cisplatine
5	Immunothérapie	Pembrolizumab	200 mg	Intraveineuse	Perfusion intraveineuse dans 100 ml de chlorure de sodium 0,9 % pendant 30 minutes avec un filtre de 0,2 micron
6	Thérapie ciblée	Bevacizumab	15 mg/m2	Intraveineuse	Perfusion intraveineuse dans 100 ml de chlorure de sodium de chlorure de sodium 0,9 % en 90 minutes.

7	Chimiothérapie	Paclitaxel	175 mg/ m²	Intraveineuse	Perfusion intraveineuse dans 500 ml de chlorure de sodium de chlorure de sodium 0,9 % en 180 minutes.
J2					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	2L de SS 0,9% ou SG5% (+4gNacl et 2gKcl) sur 6h
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Cisplatine	50 mg/m²	Intraveineuse	Dans 500 cc SS 0,9% en 1 H puis rinçage j2
5	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	1000.0 ml	Intraveineuse	1L de SS 0,9% ou SG 5%(+4g Nacl et 2g Kcl) sur 3h

[7] : Colombo, N., Dubot, C., Lorusso, D., Caceres, M. V., Hasegawa, K., Shapira-Frommer, R., Tewari, K. S., et al.(2021). Pembrolizumab for persistent, recurrent, or metastatic cervical cancer. The New England Journal of Medicine, 385(20), 1856–1867. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2112435

PEMBROLIZUMAB + CARBOPLATINE+ PACLITAXEL+/- BEVACIZUMAB J1=J21: [8]

Ordre	Type	Produit / Prescription	Dosage	Voie	Observation
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Thérapie ciblée	Bevacizumab	15mg/ m2	Intraveineuse	Perfusion intraveineuse dans 100 ml de chlorure de sodium de chlorure de sodium 0,9 % en 90 minutes.
4	Immunothérapie	Pembrolizumab	200 mg	Intraveineuse	Perfusion intraveineuse dans 100 ml de chlorure de sodium 0,9 % pendant 30 minutes avec un filtre de 0,2 micron
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	175 mg/m²	Intraveineuse	Perfusion intraveineuse dans 500 ml de chlorure de sodium de chlorure de sodium 0,9 % en 180 minutes.
6	Chimiothérapie	Careboplatine	AUC 5	Intraveineuse	Perfusion intraveineuse dans 500 ml de glucose 5% sur 60 minutes
7	Post-hydratation (Rinçage)	Chlorure De Sodium	250.0 ml	Intraveineuse	250 ml de SS 0,9%

[8] : Colombo, N., Dubot, C., Lorusso, D., Caceres, M. V., Hasegawa, K., Shapira-Frommer, R., Tewari, K. S., et al.(2021). Pembrolizumab for persistent, recurrent, or metastatic cervical cancer. The New England Journal of Medicine, 385(20), 1856–1867. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2112435